



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 14 — Crise Convulsiva Aguda e Estado de Mal Epiléptico (adulto e criança)

Abordagem da crise em curso, escalonamento farmacológico em tempo ($t_1 = 5$ min, $t_2 = 30$ min), investigação da primeira crise, crise febril, eclâmpsia, critérios de alta e transferência — cenário: pronto-socorro sem UTI e sem EEG

Código	PS-ND-14	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

A crise convulsiva é autolimitada na maioria dos casos (1–3 min). O **estado de mal epiléptico (EME)** começa, para fins de tratamento, aos **5 minutos** de crise tônico-clônica contínua ou de crises repetidas sem recuperação (t_1) e produz lesão neuronal irreversível a partir de **30 minutos** (t_2) [ILAE 2015]. O PS Natal Diegues executa integralmente a 1ª e a 2ª linhas (benzodiazepínico e antiepiléptico IV) e prepara a 3ª (anestesia + via aérea) enquanto transfere. Sem EEG local, o EME não convulsivo é diagnóstico de suspeição clínica e motivo de transferência.

Fontes de ancoragem: Trinka E, et al. *A definition and classification of status epilepticus — Report of the ILAE Task Force*. Epilepsia 2015;56:1515 [ILAE 2015]; Glauser T, et al. **Evidence-based guideline: treatment of convulsive status epilepticus in children and adults — American Epilepsy Society**. Epilepsy Curr 2016;16:48 [AES 2016]; Kapur J, et al. (ESETT) N Engl J Med 2019;381:2103; Silbergleit R, et al. (RAMPART) N Engl J Med 2012;366:591; Brophy GM, et al. Neurocritical Care Society guidelines. Neurocrit Care 2012;17:3 [NCS 2012]; NICE NG217 Epilepsies in children, young people and adults, 2022 (atualização 2025); Garzon E, et al. Estado de mal epiléptico. J Epilepsy Clin Neurophysiol 2008 (protocolo brasileiro); Yacubian EMT, et al. Tratamento de epilepsia: consenso dos especialistas brasileiros (ABN/LBE); SBP — Crise febril (Documento Científico); ILAE 2017 (classificação de crises).

Convenção de confiança: doses trazem a fonte; pediátricas conferidas com AES 2016 e sujeitas ao dose lock.

[VERIFICAR]: levetiracetam IV, midazolam IM/bucal, bomba de infusão, TC local, acesso a EEG na referência.

1. Queixa — como o paciente chega

Trazido por familiar/SAMU: "caiu e ficou se debatendo, revirou os olhos, babou, urinou", "ficou parado olhando, mexendo a boca e não respondia", "desmaiou e tremeu", "a crise não para", "está tendo uma atrás da outra e não acorda entre elas". Epiléptico conhecido: "parou o remédio", "trocou de remédio", "não dormiu / bebeu / esqueceu a dose". Sem epilepsia prévia: procurar o precipitante (seção 2.3). Criança com febre: "estava com febre e convulsionou".

Perguntas que definem a conduta (a quem presenciou)

- Hora exata do início e duração; ainda está em crise ou parou? Recuperou a consciência entre as crises?
- Como começou: generalizada desde o início, ou virou a cabeça/olhos, mexeu um lado primeiro (foco)? Aura?
- Epilepsia prévia, medicações e adesão (última dose), crises anteriores semelhantes, trauma, febre, gestação/puerpério, álcool (última dose — abstinência 6–48 h), drogas, isoniazida/tramadol/bupropiona, diabetes, DRC, câncer, HIV, anticoagulante.
- Sintomas positivos (abalos rítmicos, mordedura lateral da língua, incontinência, confusão pós-ictal longa) favorecem crise; palidez, sudorese, pródromo, recuperação imediata favorecem síncope.

2. Clínica — definições, classificação e diferenciais

2.1 Definições operacionais [ILAE 2015]

Termo	Definição	Implicação
Crise autolimitada	Interrompe-se espontaneamente em <5 min; recuperação progressiva	Proteger, observar, investigar; não medicar a crise que já acabou
EME convulsivo (t1 = 5 min)	Crise tônico-clônica ≥5 min ou ≥2 crises sem recuperação da consciência entre elas	Iniciar benzodiazepínico
t2 = 30 min	Tempo a partir do qual há lesão neuronal e sequelas	Toda a escalada deve ocorrer antes
EME focal com alteração de consciência / ausência	t1 = 10 min; t2 >60 min	Mesma escalada, menos urgência de anestesia
EME refratário	Persiste após benzodiazepínico + 1 antiepiléptico IV em dose adequada	Anestésico em infusão + IOT → UTI
EME super-refratário	Persiste ≥24 h após início do anestésico	UTI de referência com EEG contínuo
EME não convulsivo	Alteração de consciência/comportamento flutuante com atividade ictal ao EEG, sem convulsão evidente; suspeitar em coma inexplicado após EME convulsivo (20%)	Transferir para EEG; tratar empiricamente se forte suspeita

2.2 Classificação prática das crises [ILAE 2017]

Início focal (perceptiva ou disperceptiva; motora ou não motora; pode evoluir para tônico-clônica bilateral) — sugere lesão estrutural e exige imagem; **início generalizado** (tônico-clônica, ausência, mioclônica, atônica); **início desconhecido**. Sinais de lateralização (desvio cefálico/ocular, versão, postura de esgrimista, paralisia de Todd, afasia pós-ictal) devem ser registrados.

2.3 Causas de crise aguda sintomática e precipitantes (tratar a causa é parte do tratamento)

Grupo	Exemplos / pistas	Conduta específica
Metabólica	Hipoglicemia ; hiponatremia (<120), hipocalcemia, hipomagnesemia, uremia, encefalopatia hepática, hiperglicemia hiperosmolar	Glicose; NaCl 3% 100-150 mL se Na <120 com crise; gluconato de cálcio; MgSO ₄
Tóxica / abstinência	Álcool (abstinência 6-48 h), benzodiazepínico/barbitúrico (abstinência), cocaína, anfetaminas, tramadol, bupropiona, isoniazida, teofilina, organofosforados, antidepressivos tricíclicos	Benzodiazepínico é o tratamento da abstinência; isoniazida → piridoxina 1 g por g ingerido (5 g se desconhecido) ; tricíclico → bicarbonato; organofosforado → atropina/pralidoxima (Protocolo 23). Fenitoína não funciona em crise tóxica/abstinência
Estrutural / vascular	AVC (principal causa em >60 anos), HIC, HSA, trombose venosa cerebral (cefaleia + puerpério/ACO), tumor, TCE	TC de crânio; Protocolo 03
Infecciosa	Meningite/encefalite (febre, rigidez de nuca, confusão), neurocisticercose (causa frequente de epilepsia no interior paulista), abscesso, HIV/toxoplasmose, malária cerebral	Ceftriaxona 2 g 12/12 h + aciclovir 10 mg/kg 8/8 h se suspeita de encefalite herpética; dexametasona; transferir
Gestação / puerpério	Eclâmpsia (PA ≥140/90 + proteinúria/sinais; até 6 semanas pós-parto)	Sulfato de magnésio (seção 7.4), não benzodiazepínico/fenitoína como 1ª linha; transferir para obstetrícia
Epilepsia conhecida	Má adesão (causa nº 1), privação de sono, infecção intercorrente, interação (carbamazepina + macrolídeo), troca de genérico	Retomar/ajustar o esquema; dosar nível sérico se disponível
Febre em criança 6 meses-5 anos	Crise febril simples (generalizada, <15 min, única em 24 h) × complexa (focal, >15 min, recorrente)	Seção 7.5
Psicogênica (crise não epiléptica)	Olhos fechados forçados, movimentos assíncronos/pélvicos, duração longa com flutuação, choro, sem cianose, lactato/CPK normais	Diagnóstico de exclusão; não escalar benzodiazepínico; referenciar

2.4 Diferenciais do episódio

Condição	Pistas
Síncope (inclusive convulsiva)	Pródromo, palidez, sudorese, posição ereta, recuperação em segundos, abalos breves e arrítmicos; ECG obrigatório (Protocolo 25)
AIT / AVC	Sintomas negativos (fraqueza) sem abalos; Protocolo 03
Enxaqueca com aura, distúrbio do movimento, tremor, tetania, hiperventilação	Consciência preservada, curso progressivo
Distúrbio do sono, terror noturno (criança)	Contexto
Crise não epiléptica psicogênica	Ver 2.3; pode coexistir com epilepsia

3. Exame físico — o que procurar

Momento	Item	Achado / conduta
Durante a crise	Via aérea, SpO ₂ , cronômetro	Decúbito lateral, cânula de Guedel não forçada, aspirar, O ₂ ; nada na boca; não conter os membros; marcar a hora
Durante a crise	Semiologia ictal	Lado do desvio ocular/cefálico, membro que iniciou, automatismos, cianose, olhos abertos (epiléptica) × fechados (psicogênica)
Pós-ictal	Glasgow seriado, pupilas, déficit focal (Todd), rigidez de nuca, fundo de olho se possível	Recuperação progressiva esperada em 10–30 min; se não recupera → EME não convulsivo? hipoglicemia? lesão?
Pós-ictal	Língua (mordedura lateral), incontinência, luxação de ombro (posterior), fraturas, TCE, queimaduras	Documentar; radiografia se dor/deformidade
Geral	Temperatura, PA, sinais de trauma, sinais de intoxicação (pupilas, hálito, pele), estigmas de etilismo, sítios de injeção, gestação	Direciona a etiologia
Criança	Fontanela, exantema, petéquias, foco de febre, sinais meníngeos (pouco confiáveis <18 meses)	Punção lombar se sinais meníngeos, <12 meses com febre sem foco, ou ATB prévio

4. Propedêutica armada

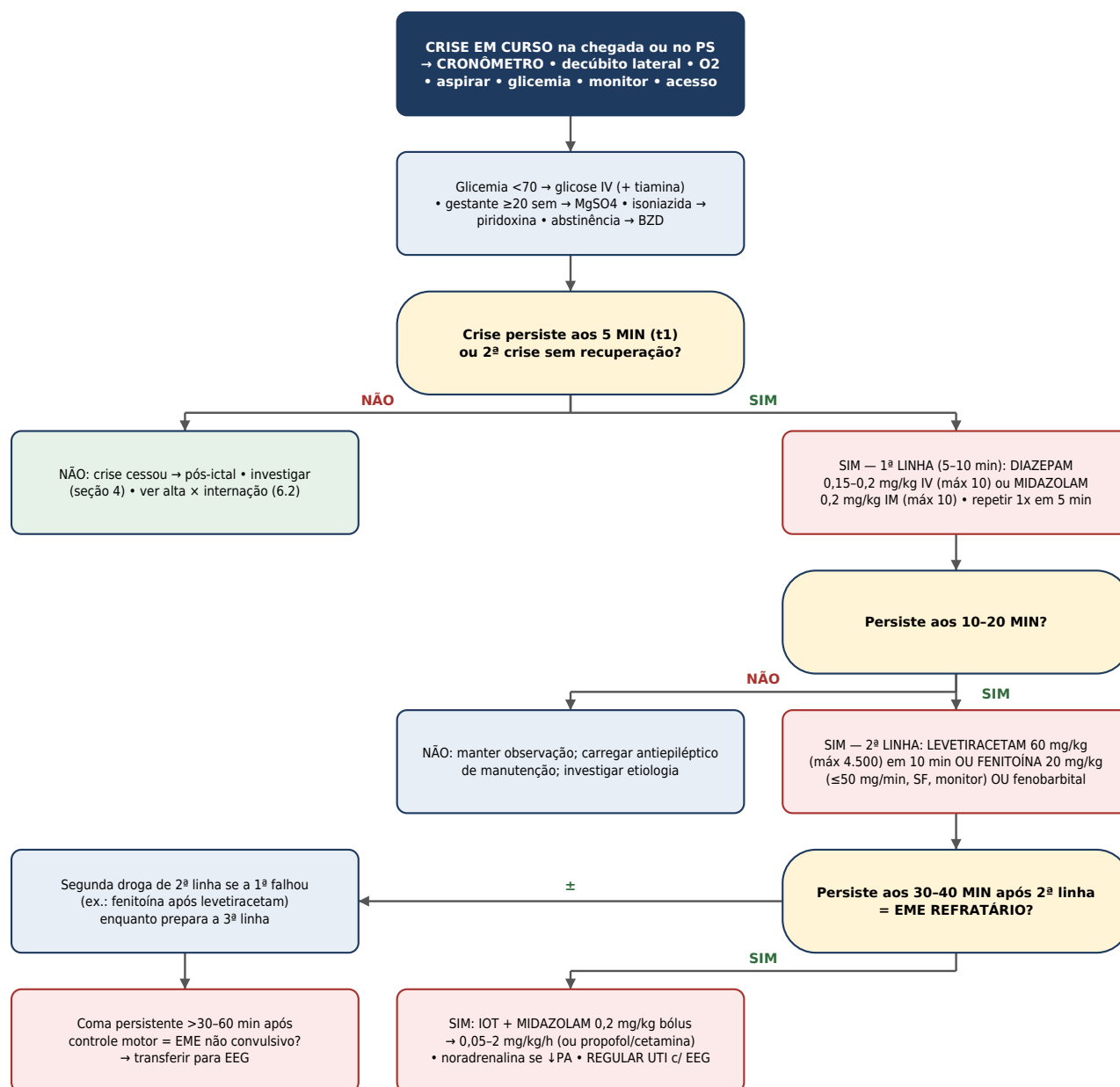
Exame	Para que serve	Quando
Glicemia capilar	Hipoglicemia é causa reversível imediata	Sempre, na chegada
Eletrólitos (Na, Ca, Mg), ureia/creatinina, glicemia, hemograma, TGO/TGP, CPK, lactato	Causa metabólica; CPK/lactato elevados apoiam crise epiléptica (lactato normaliza em 1–2 h); rabdomiólise em EME	Primeira crise e todo EME
Nível sérico do antiepiléptico (fenitoína, carbamazepina, valproato, fenobarbital)	Adesão/toxicidade	Epiléptico conhecido, se disponível [VERIFICAR]
Triagem toxicológica, etanol, β-hCG	Intoxicação; gestação (eclâmpsia, escolha de droga)	Conforme contexto
ECG	QT longo, Brugada, arritmia (síncope convulsiva); tricíclico	Todos
TC de crânio	Lesão estrutural, sangramento	Urgente: primeira crise, crise focal, déficit persistente, TCE, cefaleia, anticoagulado, imunossuprimido, câncer, >40 anos, febre, EME. Epiléptico conhecido com crise habitual e exame normal: dispensável. Sem TC local → transferir quando indicada [VERIFICAR]
Punção lombar	Meningite/encefalite, HSA com TC normal	Febre + sinais meníngeos/confusão; imunossuprimido; após TC se déficit focal/rebaixamento; ATB antes se atraso
EEG	EME não convulsivo; classificação; prognóstico	Indisponível localmente — indicação de transferência se coma persistente >30–60 min após controle motor
RM (eletiva)	Primeira crise não provocada, crise focal	Ambulatorial via referência

5. Fisiopatologia

A crise resulta de descarga neuronal excessiva e hipersincrônica por desequilíbrio entre excitação (glutamato/NMDA) e inibição (GABA-A). Em condições normais, mecanismos inibitórios encerram a crise em 1–3 min. No EME, esses mecanismos falham e, com o tempo, **os receptores GABA-A são internalizados** (perda de eficácia dos benzodiazepínicos — por isso a 1ª linha só funciona bem nos primeiros 10–30 min) enquanto **receptores NMDA são externalizados** (excitotoxicidade, base para cetamina no refratário). Sistemicamente, a fase inicial (<30 min) é hiperadrenérgica (hipertensão, taquicardia, hiperglicemia, acidose láctica, hipertermia); após 30 min há falência da autorregulação cerebral, hipotensão, hipóxia, hipoglicemia, rabdomiólise, hipercalemia e edema cerebral. A mortalidade do EME convulsivo é de 10–20% e depende sobretudo da **etiologia** e do **tempo até o controle** — cada minuto de atraso no benzodiazepínico reduz a chance de resposta.

6. Fluxo de atendimento

O relógio começa no início da crise, não na chegada. Metas [AES 2016]: benzodiazepínico aos **5 min**, antiepiléptico IV aos **10-20 min**, anestésico aos **30-40 min**. Subdosar é a causa mais comum de falha: usar a dose cheia por peso.



■ Entrada ■ Decisão ■ Conduta ■ Risco / atenção ■ Desfecho / transferência

6.1 Metas de tempo [AES 2016; NCS 2012]

Intervalo (do início da crise)	Ação
0-5 min	Estabilização (ABC, O ₂ , glicemia, acesso, monitor); tratar causas imediatas; cronometrar
5-20 min	Benzodiazepínico em dose plena; repetir 1x após 5 min
20-40 min	Antiepiléptico IV em dose de ataque (levetiracetam, fenitoína ou fenobarbital)
40-60 min	Segunda opção de 2ª linha ou anestésico + IOT ; transferência para UTI já acionada aos 20 min
Após controle	Manutenção do antiepiléptico em 6-12 h; investigação etiológica; observação ≥12-24 h no EME

6.2 Crise cessada: alta × internação

Situação	Conduta
Epilético conhecido, crise habitual, recuperação completa, exame normal, causa identificada (má adesão/privação de sono)	Alta após 2–4 h de observação com retomada/ajuste do esquema, orientações e retorno ao neurologista/APS; sem exames obrigatórios além de glicemia
Primeira crise não provocada , recuperação completa, TC e laboratório normais, adulto com acompanhante	Pode ter alta após observação de 6–12 h se houver acesso garantido a neurologia/EEG/RM em 2–4 semanas; iniciar antiepilético se crise focal, lesão na imagem, déficit ou EEG alterado (risco de recorrência >60%) — em geral discutido com a referência; se acesso incerto, internar/transferir
Crise sintomática aguda (metabólica, tóxica, febril simples)	Tratar a causa; antiepilético de longo prazo geralmente não indicado; observação até resolução da causa
Crise focal, déficit persistente, cefaleia intensa, febre + confusão, TCE, imunossuprimido, gestante, idoso >65 com primeira crise, ≥2 crises em 24 h, sem acompanhante	Internar/transferir para investigação
EME (qualquer)	Internação obrigatória; UTI se refratário ou via aérea avançada

Orientações de alta obrigatórias: não dirigir (CONTRAN: ≥1 ano livre de crises para renovar CNH; informar por escrito), evitar banho de imersão/altura/natação sozinho, privação de sono e álcool; primeiros socorros para a família; adesão medicamentosa; retorno se nova crise.

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Primeira linha — benzodiazepínicos [AES 2016 nível A; RAMPART]

Fármaco	Adulto	Criança	Observações
Diazepam IV (5 mg/mL)	0,15–0,2 mg/kg (5–10 mg) IV lento (2 mg/min), máx. 10 mg/dose; repetir 1× em 5 min	0,15–0,2 mg/kg IV (máx. 10 mg); retal 0,5 mg/kg (2–5 a) / 0,3 mg/kg (6–11 a), máx. 20 mg, se sem acesso	Não diluir; não IM (absorção errática); depressão respiratória sobretudo com 2ª dose; efeito curto (redistribuição em 20–30 min) — exige 2ª linha
Midazolam IM (5 mg/mL)	10 mg IM se >40 kg; 5 mg se 13–40 kg (RAMPART) — ou 0,2 mg/kg, máx. 10 mg	0,2 mg/kg IM (máx. 10 mg); bucal/nasal 0,2–0,3 mg/kg (máx. 10 mg)	Escolha sem acesso venoso (tão eficaz quanto IV no pré-hospitalar); IV: 0,1–0,2 mg/kg lento
Clonazepam IV (se disponível)	1 mg IV lento; repetir 1×	0,05 mg/kg	Alternativa; não há lorazepam IV no Brasil

7.2 Segunda linha — antiepilético IV em dose de ataque [AES 2016; ESETT 2019: eficácia equivalente ~45-50%]

Fármaco	Dose (adulto e criança)	Administração	Cautelas
Levetiracetam (preferência: segurança, sem interação, sem monitor obrigatório)	60 mg/kg IV, máx. 4.500 mg , dose única	Diluir em 100 mL SF/SG; infundir em 10 min ; manutenção 500-1.500 mg 12/12 h (criança 20-30 mg/kg/dia) após 12 h	Ajustar manutenção na DRC; sedação/agitação; disponibilidade IV no PS [VERIFICAR — se ausente, fenitoína]
Fenitoína (50 mg/mL — a mais disponível no SUS)	20 mg/kg IV, máx. 1.500 mg (adicional 5-10 mg/kg se persistir)	Diluir só em SF 0,9% (precipita em glicose) 250-500 mL; velocidade ≤50 mg/min (adulto), ≤25 mg/min em idoso/cardiopata, ≤1 mg/kg/min (criança); acesso calibroso com filtro; monitor cardíaco e PA ; manutenção 100 mg 8/8 h (5-7 mg/kg/dia) após 12 h	Hipotensão, bradiarritmia, BAV (parar/lentificar), flebite/síndrome da luva roxa; não é eficaz em crise por abstinência/tóxica; contraindicada em BAV 2º/3º; se já usa fenitoína, dar 10 mg/kg
Fenobarbital (100 mg/mL ou 200 mg/2 mL)	15-20 mg/kg IV, máx. 1.000-1.500 mg	Diluir; velocidade ≤50-100 mg/min (criança ≤2 mg/kg/min); manutenção 1,5-4 mg/kg/dia	Sedação profunda e depressão respiratória (sobretudo após benzodiazepínico) — preparar via aérea; hipotensão; útil em neonato e criança
Valproato IV	40 mg/kg (máx. 3.000) em 10 min	—	Indisponível no Brasil ; contraindicado em gestant e/hepatopata/mitocondriopatia
Lacosamida IV	200-400 mg em 15 min	—	Alternativa em referência; PR longo

7.3 Terceira linha — EME refratário [NCS 2012; AES 2016] — exige IOT, monitor, bomba e transferência para UTI

Fármaco	Bólus	Infusão	Observações
Midazolam	0,2 mg/kg IV (repetir 0,1-0,2 mg/kg a cada 5 min até controle, máx. 2 mg/kg)	0,05-2 mg/kg/h , titular; manter 24-48 h após controle e retirar em 12-24 h	Taquifilaxia; hipotensão; preferência no PS por familiaridade; preparo: 50 mg em 50 mL (1 mg/mL)
Propofol	1-2 mg/kg IV	20-200 mcg/kg/min (1,2-12 mg/kg/h); evitar >80 mcg/kg/min por >48 h	Hipotensão; síndrome da infusão do propofol; não em criança pequena como 1ª opção
Cetamina	1-2 mg/kg IV (dose de indução)	1-5 mg/kg/h (adjuvante ou 2ª opção)	Antagonista NMDA; preserva PA; útil com hipotensão; evidência crescente (2020+)
Tiopental/pentobarbital	3-5 mg/kg	3-5 mg/kg/h	UTI de referência; hipotensão intensa; íleo; infecção
Suporte	IOT com sequência rápida (evitar succinilcolina se hiperK/rabdomiólise — usar rocurônio 1,2 mg/kg); noradrenalina se PAM <65; sonda; controlar hipertermia (<37,5 °C); tratar acidose só se pH <7,1; corrigir eletrólitos; profilaxia de TEV		Bloqueador neuromuscular mascara a crise sem tratá-la — usar o mínimo e monitorar clinicamente/EEG na referência

7.4 Situações específicas

Situação	Conduta
Eclâmpsia (gestante ≥ 20 semanas ou até 6 semanas pós-parto)	Sulfato de magnésio 50%: 4-6 g IV em 15-20 min (8-12 mL de MgSO_4 50% em 100 mL SF) $\rightarrow$ 1-2 g/h em bomba por 24 h após a última crise; recorrência: 2 g IV adicionais. Antídoto: gluconato de cálcio 10% 10 mL IV se depressão respiratória/reflexos abolidos/diurese < 25 mL/h. Controlar PA $\geq 160/110$ (hidralazina 5 mg IV ou nifedipino 10 mg VO); decúbito lateral esquerdo; benzodiazepínico só se crise persistir apesar do Mg; transferir para obstetria com UTI
Abstinência alcoólica	Diazepam é tratamento e profilaxia (10-20 mg IV/VO a cada 1-2 h até sedação leve); tiamina 300 mg IV antes de glicose; fenitoína não previne
Hiponatremia grave (< 120) com crise	NaCl 3% 100-150 mL IV em 10-20 min (criança 2-3 mL/kg), repetir até 3x até cessar; alvo +4-6 mEq/L nas primeiras horas, máx. 8-10 mEq/L em 24 h
Isoniazida	Piridoxina IV 1 g por grama de INH ingerida (5 g se desconhecido; criança 70 mg/kg), em 5-10 min; benzodiazepínico adjuvante
Trauma cranioencefálico	Fenitoína ou levetiracetam profilático por 7 dias em TCE grave; Protocolo 29
Neurocisticercose (crise + imagem sugestiva)	Antiepiléptico; albendazol/corticoide só após avaliação de referência (edema/hidrocefalia)
Crise não epilética psicogênica confirmada	Não sedar; ambiente calmo; explicar sem confronto; referenciar (psiquiatria/neurologia)

7.5 Crise febril (6 meses-5 anos) [SBP; AAP 2011/2021]

- **Simples** (generalizada, < 15 min, única em 24 h, sem déficit, exame normal): tratar a febre e o foco; **sem exames de rotina**, sem antiepiléptico; punção lombar se sinais meníngeos, < 12 meses sem vacinação completa (Hib/pneumococo) ou uso prévio de antibiótico; observação 2-6 h; orientar recorrência (30%) e primeiros socorros; alta com o foco definido.
- **Complexa** (focal, > 15 min, recorrente em 24 h, déficit pós-ictal): investigar como crise aguda (glicemia, eletrólitos, TC/PL conforme clínica); observação $\geq 12-24$ h; discutir com pediatria/neurologia.
- Crise febril em curso ≥ 5 min: mesma escalada (midazolam bucal/IM ou diazepam IV/retal $\rightarrow$ levetiracetam ou fenitoína/fenobarbital).
- Antitérmico não previne recorrência; diazepam intermitente profilático não é recomendado de rotina.

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir

Situação	Urgência	Destino
EME refratário (após 2ª linha), IOT, anestésico em infusão	Imediata — acionar aos 20 min de crise, antes de precisar	UTI com EEG
EME controlado com 1ª/2ª linha, mas sem leito de observação monitorada por 24 h no PS	Mesmo dia	Enfermaria/UTI de referência
Coma persistente após controle motor (EME não convulsivo?), crise focal/déficit sem TC local, suspeita de meningoencefalite, HSA, TVC	Imediata	Referência com TC/EEG/neurologia
Eclâmpsia	Imediata, com MgSO_4 em curso	Obstetria com UTI
Primeira crise sem acesso garantido a investigação ambulatorial; criança com crise febril complexa ou < 12 meses	Mesmo dia	Enfermaria de referência / pediatria

8.2 Transporte e documentação

- USA do SAMU 192: monitor, O₂, aspirador, benzodiazepínico e 2ª linha prontos, bomba de infusão se anestésico, via aérea segura se Glasgow ≤8 ou sedação contínua; decúbito lateral se não intubado.
- Relatório: hora de início da crise, semiologia (foco), **cada droga com dose/hora e resposta**, glicemia, temperatura, TC/laboratório, medicações de uso e adesão, gestação, tóxicos, Glasgow atual, complicações (aspiração, trauma).
- Regulação: CROSS-SP / Central de Regulação. Hospital de referência com UTI: **Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica** (rede pactuada em 04/09/2026); EEG conforme disponibilidade da referência [VERIFICAR].

8.3 Kit e organização

- Kit de crise em cada setor: diazepam 10 mg ×4, midazolam 15 mg/3 mL ×4, fenitoína 250 mg ×6 + SF 250 mL, levetiracetam IV 500 mg ×9 [VERIFICAR], fenobarbital 200 mg ×5, MgSO₄ 50% ×4 + gluconato de cálcio, glicose 50%, tiamina, piridoxina, cânulas, aspirador, tabela de doses por peso e velocidade de infusão de fenitoína afixada.
- Cronômetro visível e registro de horários é responsabilidade da enfermagem desde a triagem.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de crises com hora de início e glicemia capilar registradas	100%
% de EME com benzodiazepínico em ≤10 min da chegada (ou ≤5 min do início se no PS)	≥90%
% de EME com 2ª linha em dose plena (≥18 mg/kg fenitoína ou 60 mg/kg levetiracetam) em ≤20 min do benzodiazepínico	≥80%
% de fenitoína administrada com monitor e velocidade documentada	100%
% de EME refratário com regulação acionada antes de 30 min de crise	≥90%
% de primeiras crises com TC (local ou por transferência) e orientação de não dirigir documentada	≥90%
Aspiração/IOT não planejada, hipotensão <90 após fenitoína (eventos)	Registrar; tendência de queda

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
2ª linha de escolha	AES 2016/ESETT: levetiracetam, fosfenitoína e valproato equivalentes; valproato IV inexistente no Brasil e fosfenitoína é rara; fenitoína é a mais disponível no SUS. Adotado: levetiracetam preferido se disponível, fenitoína como padrão SUS, fenobarbital como 3ª opção/pediatria
Dose de levetiracetam	ESETT: 60 mg/kg (máx. 4.500); alguns protocolos: 40 mg/kg. Adotado 60 mg/kg
Midazolam IM por faixa de peso	RAMPART: 10 mg >40 kg / 5 mg 13–40 kg; alternativa 0,2 mg/kg. Adotadas ambas
Diazepam retal / midazolam bucal	Disponibilidade das apresentações [VERIFICAR]; no PS, IM/IV são o padrão
Cetamina na 3ª linha	Evidência observacional crescente; NCS 2012 não a lista como 1ª opção. Adotada como opção em hipotensão
Antiepiléptico após primeira crise	ILAE/AAN: individualizar por risco de recorrência; decisão preferencialmente com neurologia. Sem regra única no PS
Crise febril e punção lombar	AAP 2011: PL opcional em 6–12 meses com vacinação incompleta; SBP mantém recomendação por sinais clínicos. Adotada a redação combinada
TC local e EEG na referência	Definem fluxos de transferência [VERIFICAR/PACTUAR]

10. Referências

- Trinka E, Cock H, Hesdorffer D, et al. A definition and classification of status epilepticus — Report of the ILAE Task Force on Classification of Status Epilepticus. *Epilepsia* 2015;56(10):1515-1523.
- Glauser T, Shinnar S, Gloss D, et al. Evidence-based guideline: treatment of convulsive status epilepticus in children and adults: report of the Guideline Committee of the American Epilepsy Society. *Epilepsy Curr* 2016;16(1):48-61.
- Kapur J, Elm J, Chamberlain JM, et al. Randomized trial of three anticonvulsant medications for status epilepticus (ESETT). *N Engl J Med* 2019;381:2103-2113. Silbergleit R, et al. Intramuscular versus intravenous therapy for prehospital status epilepticus (RAMPART). *N Engl J Med* 2012;366:591-600.
- Brophy GM, Bell R, Claassen J, et al. Guidelines for the evaluation and management of status epilepticus. *Neurocrit Care* 2012;17(1):3-23.
- NICE. Epilepsies in children, young people and adults. NICE guideline NG217, 2022 (atualização 2025).
- Fisher RS, Cross JH, French JA, et al. Operational classification of seizure types by the ILAE. *Epilepsia* 2017;58(4):522-530.
- Garzon E, et al. Estado de mal epiléptico. *J Epilepsy Clin Neurophysiol* 2008;14(Suppl 2):7-11. Yacubian EMT, et al. Tratamento de epilepsia: consenso dos especialistas brasileiros. *Arq Neuropsiquiatr* 2008.
- Sociedade Brasileira de Pediatria — Departamento de Neurologia. Crise febril: documento científico. American Academy of Pediatrics. Febrile seizures: clinical practice guideline. *Pediatrics* 2011;127:389.
- Ministério da Saúde. Protocolo de Atenção à Saúde — Pré-eclâmpsia/eclâmpsia (sulfato de magnésio); FEBRASGO. Pré-eclâmpsia, 2023.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de crise convulsiva/EME (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração